

Questões terapia nutricional prova 3

1. A contagem de carboidratos deve ser indicada para todos os indivíduos com diabetes mellitus? Justifique

A contagem de carboidratos não é indicada para todos os indivíduos com diabetes mellitus. Ela é mais útil principalmente para pacientes que utilizam insulina, especialmente em esquemas basal-bolus ou múltiplas doses diárias, pois permite ajustar a dose de insulina de acordo com a quantidade de carboidrato ingerida. Para pacientes que não usam insulina ou têm controle mais simples, outras estratégias alimentares podem ser suficientes.

2. O índice glicêmico pode ser utilizado isoladamente como estratégia dietética no tratamento do DM? Explique.

O índice glicêmico não deve ser utilizado isoladamente como estratégia dietética no tratamento do diabetes. Isso porque o controle glicêmico não depende apenas da velocidade de absorção do carboidrato, mas também da quantidade ingerida, da composição da refeição e da presença de outros macronutrientes. Portanto, ele pode ser uma ferramenta complementar, mas não substitui o planejamento alimentar global.

3. Pacientes com DM2 em uso de agonistas de GLP-1 e/ou GIP necessitam de aumento do aporte proteico, além das recomendações? Justifique.

Sim, pacientes com DM2 em uso de agonistas de GLP-1 e/ou GIP podem necessitar de atenção ao aporte proteico, especialmente em contexto de perda de peso. Os slides mostram que durante a redução ponderal ocorre perda de massa magra, cerca de 25%, e por isso é recomendado um consumo proteico de aproximadamente 1,2 a 1,5 g/kg/dia para preservar a massa muscular.

4. Descreva o impacto metabólico da ingestão proteica no DM1 e DM2

A ingestão proteica impacta o metabolismo de forma diferente. No DM2, ela é importante para preservação de massa magra, especialmente em contextos de perda de peso e risco de sarcopenia. No DM1, embora não esteja detalhado diretamente nos slides, a proteína pode influenciar a glicemia de forma indireta, contribuindo para produção de glicose ao longo do tempo. De forma geral, a proteína ajuda na saciedade e no controle metabólico, mas deve ser ajustada conforme o contexto clínico.

5. No manejo nutricional do DM, a quantidade de macronutrientes é mais importante que o padrão alimentar? Justifique.

A quantidade de macronutrientes não é mais importante que o padrão alimentar isoladamente. O tratamento nutricional deve considerar o conjunto da dieta, incluindo qualidade dos alimentos, distribuição ao longo do dia, associação com medicamentos e estilo de vida. Os slides reforçam a importância de estratégias integradas, não apenas da composição quantitativa.

6. Em pacientes com DM2 em uso prolongado de metformina, deve-se priorizar a ingestão de quais micronutrientes?

Em pacientes com DM2 em uso prolongado de metformina, deve-se priorizar a vitamina B12. Os slides destacam que a metformina está associada à deficiência de

cobalamina, sendo necessária avaliação periódica e atenção à ingestão desse micronutriente, especialmente em uso prolongado ou em doses elevadas.

7. A resposta glicêmica no DM é influenciada apenas pelos carboidratos?

Explique o papel dos demais macronutrientes.

Não, a resposta glicêmica não é influenciada apenas pelos carboidratos. Embora eles sejam o principal determinante, outros macronutrientes também interferem. As proteínas podem influenciar a glicemia de forma tardia e as gorduras podem retardar o esvaziamento gástrico, alterando a velocidade de absorção da glicose. Além disso, hormônios como incretinas também participam da resposta metabólica.

8. Descreva a conduta terapêutica recomendada para o tratamento da hipoglicemia nível 1 e severa?

A hipoglicemia nível 1 geralmente é tratada com ingestão de carboidratos de rápida absorção. Já a hipoglicemia severa exige intervenção imediata, podendo incluir administração de glicose por via intravenosa ou glucagon, dependendo da situação clínica.

9. Qual o papel da automonitorização?

A automonitorização tem papel fundamental no manejo do diabetes, pois permite melhor controle glicêmico e ajuste das doses de insulina, da alimentação e da atividade física. Ela contribui para melhora da qualidade de vida e prevenção ou redução da progressão de complicações micro e macrovasculares.

10. No DM1 quais os cuidados prévios antes da prática de atividade física?

Essa informação também não aparece de forma direta nos slides. Com base no raciocínio do conteúdo, antes da atividade física no DM1 é importante avaliar a glicemia, ajustar a ingestão alimentar e, se necessário, a dose de insulina, para evitar hipoglicemia durante ou após o exercício.